TOME 10 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Gériatrie

Collège National des Enseignants de Gériatrie (CNEG) • 41 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 10 : Gériatrie.

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 41 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège National des Enseignants de Gériatrie (CNEG).
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	41 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 10

Collège National des Enseignants de Gériatrie (CNEG) • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 10 • Gériatrie (41 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

• Chapitre 01 : Vieillissement (123, 130)
• Chapitre 02 : Autonomie, Dépendance chez le sujet âgé (133)
• Chapitre 03 : Chutes chez la personne âgée (131)
• Chapitre 04 : Troubles nutritionnels chez le sujet âgé (252)
• Chapitre 01 — Vieillissement (123, 130)
• Stratégies pour ralentir le vieillissement
• • Maintien/Reprise d’une activité physique adaptée
• • Alimentation adaptée (ni trop dans la jeunesse, ni trop peu dans la vieillesse)
• Vieillissement réussi et Vieillissement en bonne santé
• Vieillissement normale : causes - conséquences
• Principaux mécanismes biologiques impliqués dans le vieillissement
• Détails sur les mécanismes de vieillissement cellulaire
• Instabilité génomique
• Facteurs endogènes (réplication cellulaire, radicaux libres) et exogènes (environnementaux) causent des lésions de l'ADN nucléaire et mitochondrial, compromettant l'intégrité génomique. Avec l'âge, ces lésions augmentent tandis que les mécanismes de réparation diminuent. Ce déséquilibre, déterminant le vieillissement des organes, dépend de facteurs génétiques et environnementaux.
• Raccourcissement des télomères
• • Le télomère : extrémité chromosomique composée d'une séquence répétitive non codante (GGGTTA), raccourcissant à chaque réplication. Longueur fixée à la naissance (9 kbases).
• • La télomérase : enzyme remplaçant la partie télomérique perdue, principalement active dans les cellules sexuelles et souches.
• Le raccourcissement des télomères lors des réplications rend le chromosome vulnérable. Ce phénomène est associé à un risque accru de mortalité et de maladies dégénératives liées au vieillissement.
• Altération épigénétiques
• L'épigénétique étudie les changements d'activité génique sans modification de la séquence d'ADN, transmissibles lors des divisions cellulaires. Ces modifications sont réversibles, contrairement aux mutations.
• Ces altérations concernent principalement la méthylation de l'ADN, l'acétylation des histones et le remodelage de la chromatine.
• L'épigénétique influence significativement le vieillissement biologique et la longévité.
• Perte de protéostasie
• La protéostasie assure l'organisation et le repliement correct des protéines, essentiels au fonctionnement cellulaire. Divers stress (oxydant, thermique) peuvent altérer ce processus, favorisant l'apparition de maladies neurodégénératives ou cancéreuses liées au vieillissement.
• Défaut de détection des éléments nutritifs (protéine kinase TOR)
• La détection des nutriments assure une nutrition optimale pour le métabolisme et la croissance. La protéine kinase TOR (cible de la rapamycine) en est le principal médiateur, régulant la croissance cellulaire, la synthèse protéique et l'autophagie.
• Avec l'âge, ce processus se détériore, perturbant les voies de détection nutritionnelle. Ces dysfonctionnements altèrent le métabolisme, favorisant obésité, diabète et autres maladies métaboliques.

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Vieillissement (123, 130)

Chapitre 02 : Autonomie, Dépendance chez le sujet âgé (133)

Chapitre 03 : Chutes chez la personne âgée (131)

Chapitre 04 : Troubles nutritionnels chez le sujet âgé (252)

Chapitre 01 — Vieillissement (123, 130)

Stratégies pour ralentir le vieillissement

- Maintien/Reprise d'une activité physique adaptée
- Alimentation adaptée (ni trop dans la jeunesse, ni trop peu dans la vieillesse)

Vieillissement réussi et Vieillissement en bonne santé

Vieillissement normale : causes - conséquences

Principaux mécanismes biologiques impliqués dans le vieillissement

Détails sur les mécanismes de vieillissement cellulaire

Instabilité génomique

Facteurs endogènes (réplication cellulaire, radicaux libres) et exogènes (environnementaux) causent des lésions de l'ADN nucléaire et mitochondrial, compromettant l'intégrité génomique. Avec l'âge, ces lésions augmentent tandis que les mécanismes de réparation diminuent. Ce déséquilibre, déterminant le vieillissement des organes, dépend de facteurs génétiques et environnementaux.

Raccourcissement des télomères

- Le télomère : extrémité chromosomique composée d'une séquence répétitive non codante (GGGTTA), raccourcissant à chaque réplication. Longueur fixée à la naissance (9 kbases).

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Gériatrie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Restriction calorique	- Restriction calorique ralenti le vieillissement biologique et allonge la durée de vie chez certaines espèces animales -> mais pas d'effet significatif chez les primates, peu efficace voire délétère chez l'Homme - Régime hypocalorique sont à proscrire le plus souvent (substrat le plus rapidement consommé en période de jeune ou d'agression est le muscle)
Activité physique	Activité physique s'oppose à plusieurs effets du vieillissement, avantages même si débutée à un âge avancé -> muscle, os, métabolisme, respiratoire, cognitif …
Traitement hormonal	Traitement hormonal substitutif de la ménopause (sur les signes fonctionnels de la ménopause et de l'ostéoporose)
Régime alimentaire	- Acides gras Oméga-3 (n-3) : peut avoir un effet bénéfique sur l'état cognitif - Régime méditerranéen avec huile d'olive extra-vierge : aurait un effet protecteur pour pathologies liées au vieillissement (cardiovasculaires, neurodégénératives, cancers)
Anti-oxydants	- Exemples : vitamines E, C, A, ginkgo biloba - Effets protecteurs sur le vieillissement du système cardiovasculaire et SNC (dans travaux expérimentaux, études observationnelles, et rarement dans études interventionnelles à court terme) - Toutes les études interventionnelles à long terme sur le sujet se sont avérées négatives

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Gériatrie

Caractéristique	Description / Données Cliniques
Vieillissement en bonne sante■	- Peu de maladies chroniques - Capacité de re■agir en pre■sence d'un stress - Vivre sans de■pendance, Faible diminution des capacite■s fonctionnelles
Vieillissement re■ussi	Vieillissement re■ussi sort du cadre seul de la ge■riatrie, car elle inte■gre tous les aspects psychosociaux ■■, propres a■ chaque individu, ce qui, pour un individu donne■, est plus important que les aspects me■dicaux et biologiques (ainsi, on peut e■tre de■pendant et avoir un vieillissement re■ussi)
Comment vieillir en forme ?	Pour vieillir « en forme », il est donc essentiel de mener tout au long de sa vie des activite■s qui entretiennent les re■serves fonctionnelles et mettent en jeu les capacite■s d'adaptation de l'organisme, et d'autre part : - Entretenir/Ame■liorer le capital de base intellectuel, physique et relationnel - Pre■venir les maladies accessibles a■ une pre■vention (grippe, maladies cardiovasculaires ...) - Prise en charge pre■coce des maladies ou troubles susceptibles d'entrai■ner des de■sordres en cascade d'autres fonctions de l'organisme (troubles de la marche, e■tat de■pressif, alte■ration de l'e■tat nutritionnel ...)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 10

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 10 • Gériatrie (41 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège National des Enseignants de Gériatrie (CNEG)
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (41 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.